

AULA • NÍVEL BÁSICO

RCP e DEA: os primeiros minutos

Reconhecer. Acionar. Comprimir.

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO

Material didático de apoio

Fonte: Base: AHA 2025 — Part 7: Adult Basic Life Support, 2025 Guidelines for CPR and ECC (Circulation 2025;152(suppl 2), DOI 10.1161/CIR.0000000000001369) [1];
identificação do instrutor fornecida pelo usuário.



Ilustração: unDraw (licença livre), cores adaptadas • cena de apoio

APRESENTAÇÃO

Quem conduz esta conversa

1º Tenente Geraldo

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

FORMAÇÃO ACADÊMICA



Engenharia Química — UFPE • Pós-graduação em APH

ATUAÇÃO OPERACIONAL



CBMPE: operações de APH; resgate veicular; piloto de embarcações públicas; incêndio florestal

Especialista em ocorrências com produtos perigosos — CBMBA

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

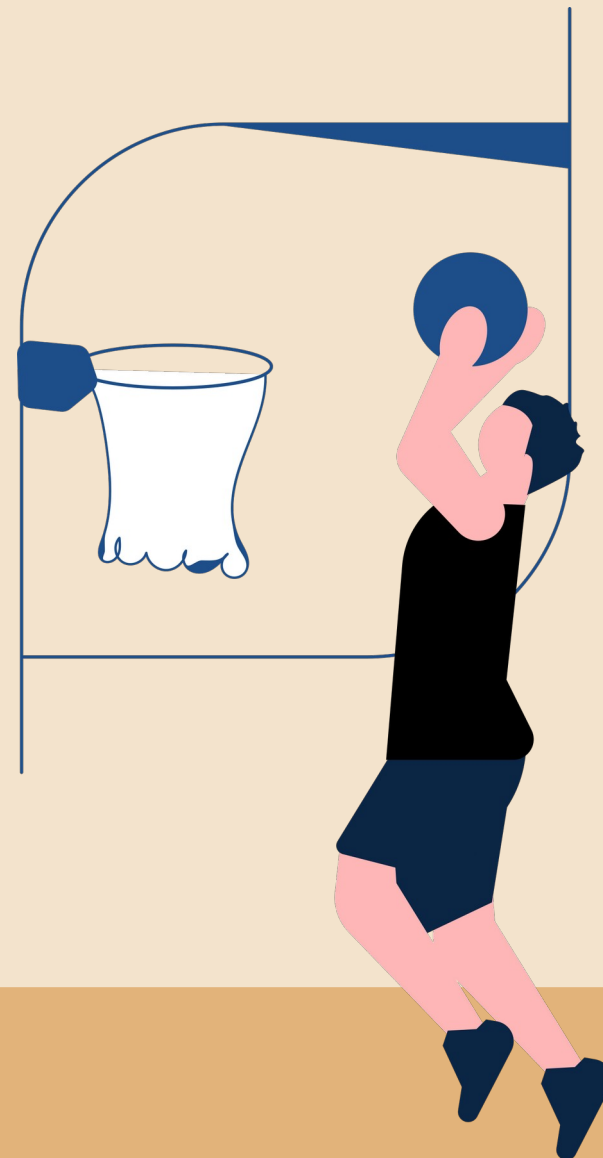
Uma queda na quadra

- Um homem de cerca de 50 anos cai na quadra, sem bater a cabeça em nada.
- Chamam o nome e tocam os ombros: ele não responde.
- Ele não respira normalmente — faz um ruído parecido com um suspiro.



O que fazer nos próximos 30 segundos?

Fonte: Critério de reconhecimento: AHA 2025 — Part 7, §5.1 (inconsciente + respiração ausente ou anormal = parada cardíaca; COR 1 / C-LD). História: simulação editorial.



Resposta — Uma queda na quadra



Conduta correta

- 1 Não responde e não respira normalmente: presume-se parada cardíaca.
- 2 O ruído de suspiro (gasping) não é respiração.
- 3 Assumir a parada — não esperar para ter certeza.



Erros comuns

- ✗ Esperar para ter certeza antes de agir.
- ✗ Tratar o suspiro como se fosse respiração normal.



Em seguida: acionar a emergência e comprimir — é o que os próximos slides mostram.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

O critério que muda a decisão



Trate como parada cardíaca



Não responde ao chamado e não respira normalmente: trate como parada cardíaca.



Suspiro, ruído ou respiração ruidosa e irregular não contam como respiração normal.



Não se espera confirmação para começar.



Não é RCP



Se responde e respira normalmente, não é RCP: é observar e chamar ajuda.



Ilustração vetorial original • não demonstra técnica

Cadeia de sobrevivência



1

Reconhecer

não responde e não
respira
normalmente.



2

Acionar

192 (SAMU) ou 193
(Corpo de
Bombeiros).



3

Comprimir

100 a 120 por
minuto, sem pausa
longa.



4

Desfibrilar

DEA ligado o quanto
antes.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor • esquema não demonstra técnica

ACIONAR

Sozinho: acionar primeiro, comprimir em seguida



Sozinho: acione a emergência e comece as compressões logo depois.



Na ligação, diga três coisas: local exato, o que aconteceu e o que já foi feito.



Fique no telefone e siga as orientações do atendente.



Com mais gente: um liga e busca o DEA enquanto o outro já comprime.



Superfície firme; colchão faz o tórax afundar junto com o corpo.

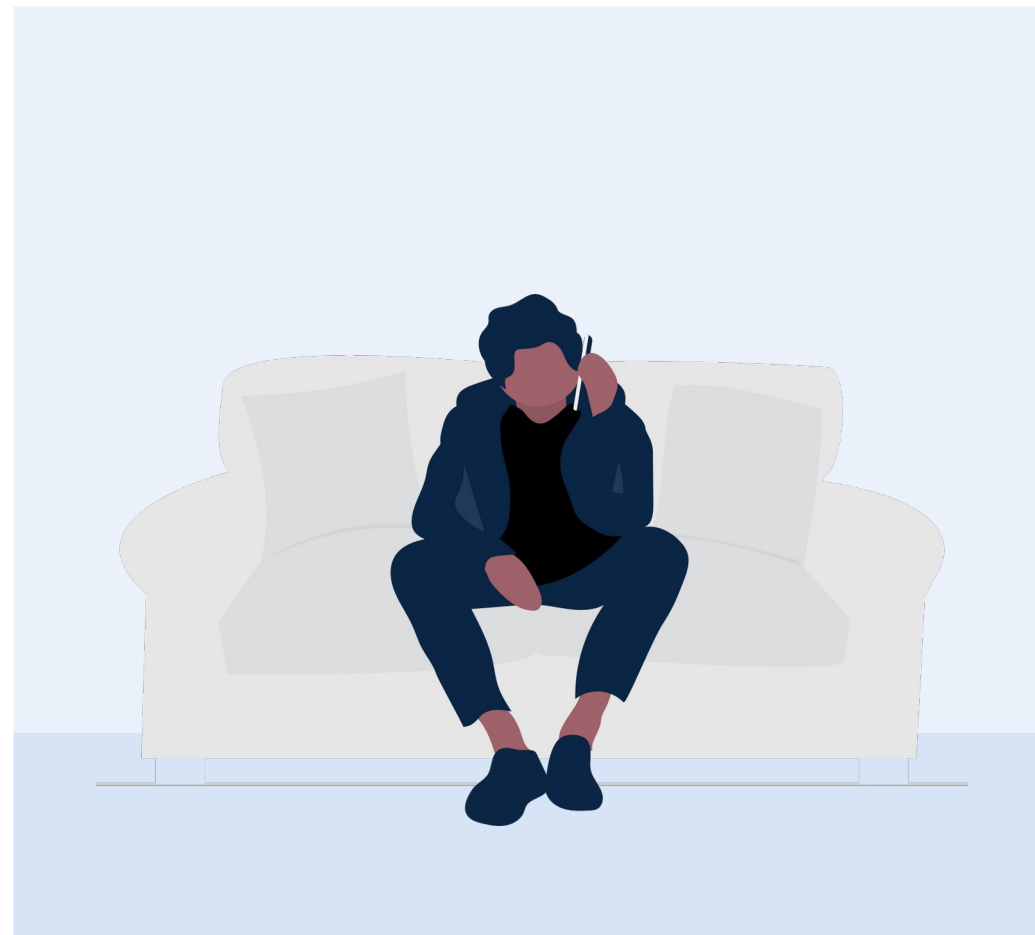


Ilustração: unDraw (licença livre), cores adaptadas • cena de apoio

O que deve ser feito primeiro em caso de emergência?

Opção 1

RESPOSTA CORRETA

Reconhecer



Chamar ajuda



Intervir

Opção 2

NÃO É A REGRA GERAL

Reconhecer



Intervir



Chamar ajuda

NA PRÁTICA



Com celular: ligue no viva-voz e comece enquanto fala com o atendente.



Com mais gente: um liga e busca o DEA; o outro já comprime.



Exceção: sozinho e sem telefone — veja o próximo slide.



Ilustração: unDraw (licença livre) • pictogramas: Health Icons e Phosphor

A exceção: socorrista sozinho e sem telefone



Sozinho, sem telefone.
A vítima não responde
e não respira
normalmente.



ADULTO — OU CRIANÇA COM COLAPSO SÚBITO PRESENCIADO

Primeiro acionar 192/193 e trazer o DEA; depois iniciar a RCP.

AHA 2025 — Part 7 (COR 1 / B-NR) • algoritmo pediátrico AHA/AAP 2025



CRIANÇA — COLAPSO NÃO PRESENCIADO

Primeiro cerca de 2 minutos de RCP; se continuar sozinho, sair para acionar e buscar o DEA.

AHA/AAP 2025 — Pediatric BLS Algorithm, 1 socorrista

DIVERGÊNCIA: ERC 2025 = 1 MINUTO



AFOGADO

Primeiro RCP com ventilações; o DEA vem depois e não pode atrasar a RCP.

AHA 2025 — Part 10, §11 Drowning (COR 1 / B-NR)

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres) • esquema original

Por que a ordem muda?



Adulto

CAUSA

Parada geralmente súbita, de origem cardíaca, com o sangue ainda oxigenado.

POR ISSO

O choque precoce do DEA é o que mais ajuda: acionar e trazer o DEA vem primeiro.



Criança

CAUSA

A parada costuma vir de falha respiratória ou choque, não do coração. Ritmos chocáveis são raros.

POR ISSO

Oxigênio e circulação já: cerca de 2 min de RCP antes de sair.



Afogado

CAUSA

A submersão tira o oxigênio: para primeiro a respiração, depois o coração. Ritmo chocável em 2%–12%.

POR ISSO

A prioridade é ventilar: RCP com ventilações antes do DEA.



Sozinho

CAUSA

Uma pessoa não faz duas coisas ao mesmo tempo: sair para ligar é ficar minutos sem RCP.

POR ISSO

Decide-se pela causa provável. Com celular, não há dilema: viva-voz e comprimir.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Os quatro números da compressão



100–120 /min

Frequência: 100 a 120 compressões por minuto.



5 a 6 cm

Profundidade: pelo menos 5 cm no adulto médio, sem passar de 6 cm.



Recuo total

Recuo: deixar o tórax voltar por completo entre as compressões.



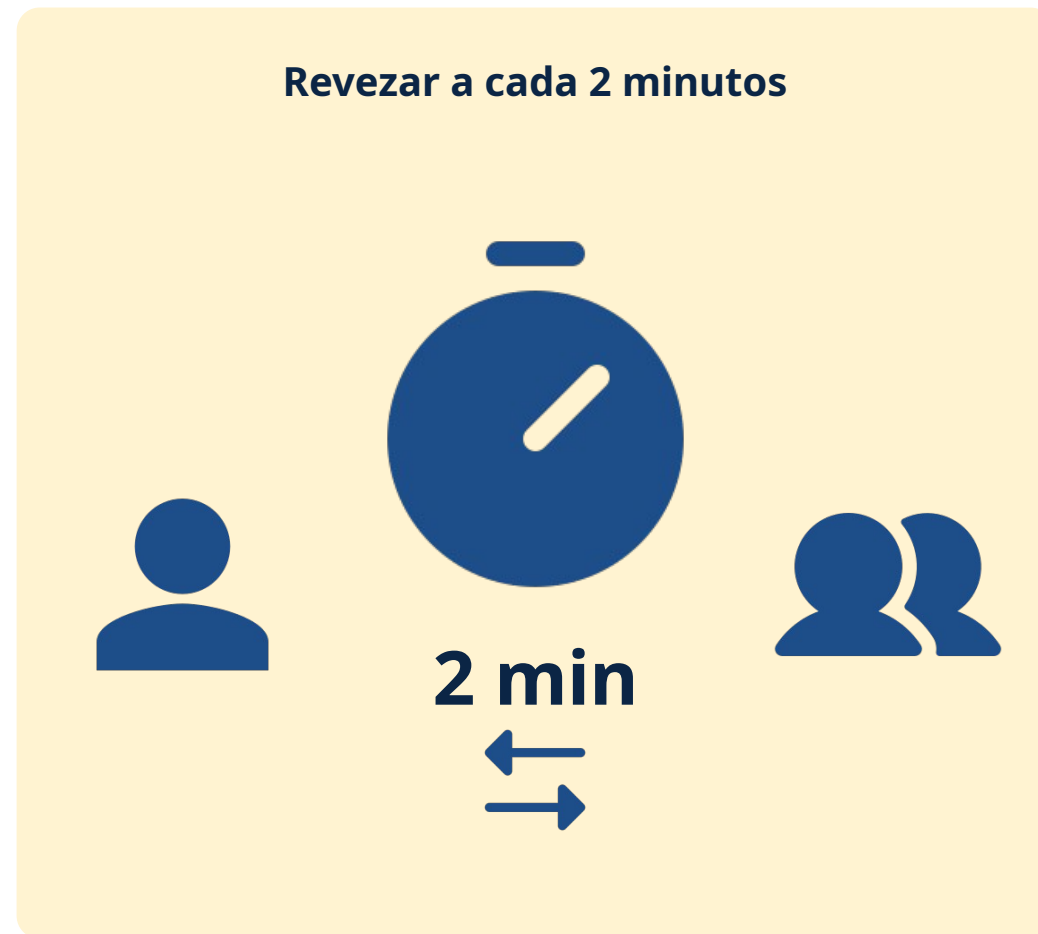
Pausas mínimas

Pausas: as mais curtas possíveis, na menor fração de tempo possível.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor • técnica só com manequim e instrutor

Manter a qualidade até a ajuda chegar

-  Com 2 ou mais pessoas: revezar quem comprime a cada 2 minutos.
-  A profundidade das compressões cai depois de 90 a 120 segundos.
-  **Não apoiar o peso do corpo sobre o tórax entre as compressões.**
-  Não há indicação rotineira de dispositivo mecânico para o público em geral.



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Ventilações: 30 compressões por 2 ventilações



Com treinamento e sem via aérea avançada:
30 compressões e 2 ventilações.



Cada ventilação em cerca de 1 segundo.



Volume apenas suficiente para ver o tórax
subir.



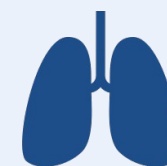
**Ventilar pouco e ventilar demais fazem
mal do mesmo jeito.**

Proporção do ciclo

30 : 2



compressões



ventilações

Esquema original • pictogramas Health Icons • técnica: demonstração ao vivo

Quando ventilar não é possível ou não é indicado



Compressões contínuas



Sem treinamento, sem vontade ou sem material: compressões contínuas.



Não interromper a compressão para tentar ventilar.



Com pulso, sem respiração normal



Pessoa com pulso mas sem respiração normal: 1 ventilação a cada 6 segundos.



Nesse caso específico não se comprime — aqui se ventila.

Ilustração vetorial original • não demonstra técnica

DEA: ligar, colar, afastar, chocar, voltar a comprimir



1

Ligar

Ligar o aparelho: ele fala o que fazer.



2

Colar as pás

Expor o tórax e colar as pás onde o próprio DEA mostra.



3

Afastar

Afastar todos durante a análise e durante o choque.



4

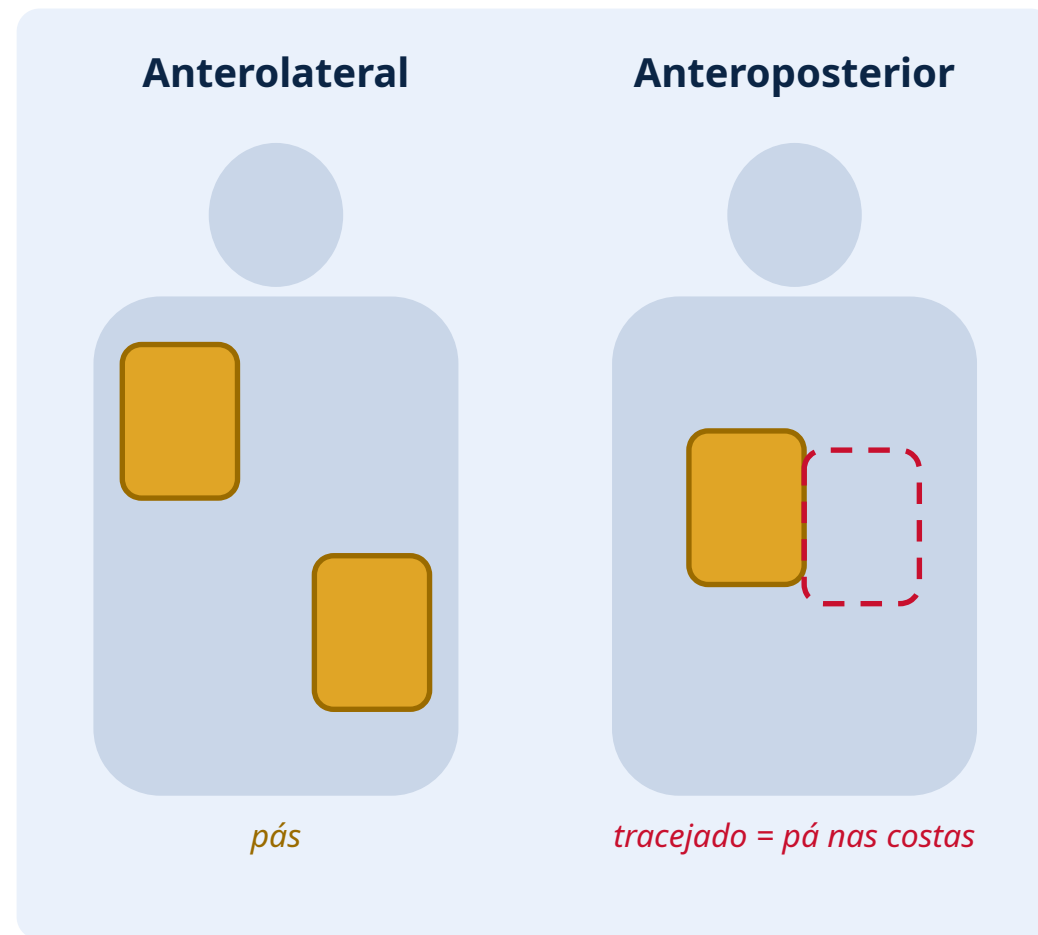
Voltar a **comprimir**

Depois do choque, voltar a comprimir imediatamente.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor • esquema não demonstra técnica

Onde as pás vão

-  Posição anterolateral ou anteroposterior, conforme o aparelho mostra.
-  No adulto, eletrodo com diâmetro maior que 8 cm.
-  Tórax molhado ou muito sujo: secar antes de colar.
-  Ajustar o sutiã pode ser razoável; não é necessário retirá-lo.



Esquema vetorial original • siga sempre a figura do próprio aparelho

RCP antes e depois do choque

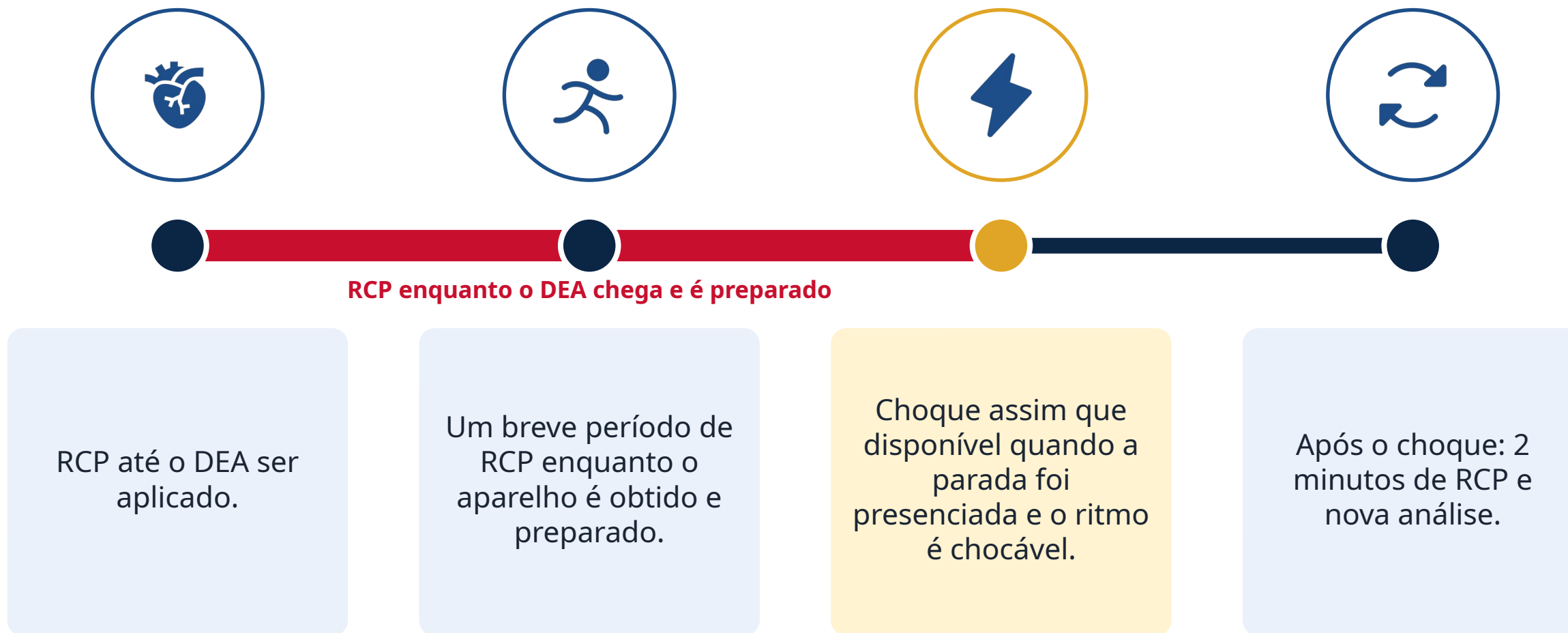


Ilustração vetorial original • não demonstra técnica

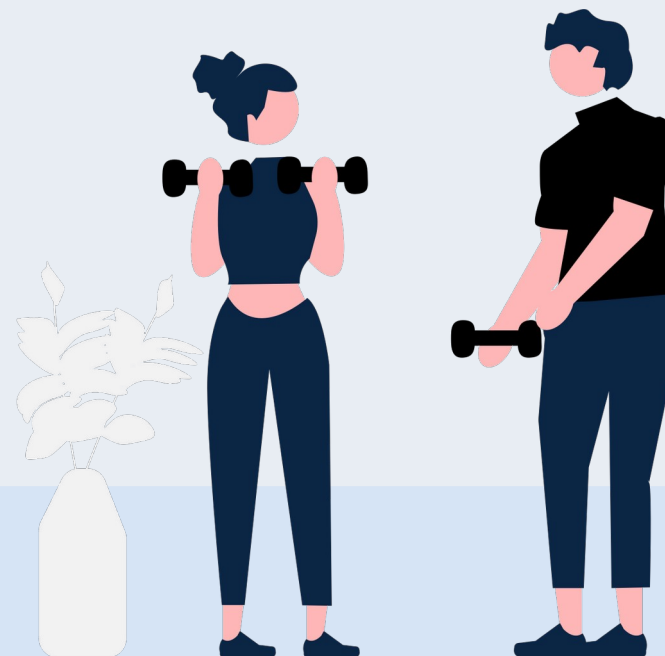
A academia com o DEA na parede

- Numa academia, um homem de 55 anos desmaia durante o treino.
- Não responde e não respira normalmente.
- Há um DEA na parede, a 20 metros; o instrutor está sozinho com um aluno.



Primeira decisão, em 30 segundos: o que vem antes de tudo?

Fonte: AHA 2025 — Part 7, §5.1, §7.2, §7.3 e §9.1; AHA — Adult Cardiac Arrest Algorithm 2025. Caso simulado.



Resposta — A academia com o DEA na parede



Conduta correta

- 1 Assumir a parada cardíaca.
- 2 Acionar a emergência e iniciar compressões imediatamente.
- 3 Mandar alguém buscar o DEA.



Erros comuns

-  Sair correndo para buscar o DEA antes de qualquer compressão: não se atrasa o início da RCP para obter o DEA.
-  Checar o pulso por um minuto: contraria o limite de 10 segundos e é conduta de profissional de saúde.



O DEA não é pré-requisito para começar a comprimir.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

A copa do escritório, duas pessoas

- Na copa do escritório, um colega de 60 anos cai da própria altura e fica imóvel.
- Duas pessoas estão presentes: uma tem treinamento, a outra não.
- Não há DEA no andar.



O que cada uma faz, e em que ordem?

Fonte: Critério e sequência: AHA 2025 — Part 7, §5.1, §7.2 e §8.2. História: simulação editorial.



Resposta — A copa do escritório, duas pessoas



Quem tem treinamento

- ✓ Conduz as compressões.
- ✓ Pede que alguém busque o DEA mais próximo.



Quem não tem treinamento

- ✓ Liga para 192/193: local, o que aconteceu e o que já foi feito.
- ✓ Organiza o acesso do serviço ao andar.



Quem não ventila não é obstáculo: compressões contínuas até a ajuda assumir. E não se manda buscar o DEA quem já está comprimindo.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Sozinha em casa, com o telefone na mesa

- Em casa, um morador de 70 anos desmaia na sala enquanto a filha está no local.
- Ele não responde ao chamado e não respira normalmente.
- Ela está sozinha e o telefone está na mesa.



Qual é a primeira coisa a fazer?

Fonte: Critério, ordem de acionamento e ventilação: AHA 2025 — Part 7, §5.1, §7.1 e §8.2; numeração de emergência do Brasil. História: simulação editorial.



Resposta — Sozinha em casa, com o telefone na mesa



Conduta correta

- 1 Chamar a emergência em viva-voz.
- 2 Começar as compressões imediatamente, seguindo as orientações do atendente enquanto comprime.



Erros comuns

- ✗ Perder tempo procurando pulso: o público geral não faz checagem de pulso.
- ✗ Esperar para ver se melhora.



Com treinamento: 30 compressões e 2 ventilações. Sem treinamento ou sem como ventilar: compressões contínuas.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Caso da turma: a decisão dos primeiros 30 segundos



Caso: homem de 55 anos desmaia na academia; não responde e não respira normalmente.

A

Buscar o DEA correndo, antes de qualquer compressão.

B

Checar o pulso por um minuto para ter certeza.

C

Assumir parada, acionar a emergência, comprimir e mandar alguém buscar o DEA.

D

Sentar a pessoa e oferecer água.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Resposta — a decisão dos primeiros 30 segundos

RESPOSTA CORRETA



Assumir parada, acionar a emergência, comprimir e mandar alguém buscar o DEA.



Por que não

Atrasa a compressão: a diretriz é explícita em não atrasar a RCP para obter o DEA.



Por que não

Contraria o limite de 10 segundos da checagem de pulso, e checar pulso é conduta de profissional de saúde.



Por que não

É inútil e atrasa o atendimento.



Quando o DEA chegar: ligar, colar as pás, afastar todos, chocar se indicado e voltar a comprimir sem pausa para checar o ritmo.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Recapitulando: reconhecer, acionar, comprimir, desfibrilar



Reconhecer:

inconsciente e sem respiração normal — suspiro não é respiração.



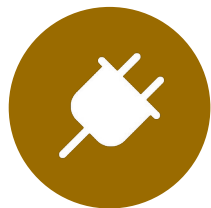
Acionar:

192/193, com local, o que aconteceu e o que já foi feito.



Comprimir:

100 a 120 por minuto, 5 a 6 cm, recuo completo, pausas mínimas.



Desfibrilar:

DEA ligado o quanto antes e compressões retomadas logo após o choque.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 1 — Frequência das compressões



Qual é a frequência de compressões torácicas recomendada para o adulto em parada cardíaca?

A

60 a 80 compressões por minuto

B

120 a 140 compressões por minuto

C

100 a 120 compressões por minuto

D

O mais rápido que o socorrista conseguir

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 2 — Profundidade da compressão



Qual é a profundidade de compressão recomendada no adulto médio?

A

Pelo menos 5 cm, evitando passar de 6 cm

B

Pelo menos 2 cm, sem limite máximo

C

Exatamente 8 cm em todos os adultos

D

A profundidade é definida apenas pelo retorno do tórax, sem valor de referência

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 3 — Proporção entre compressões e ventilações



No adulto em parada cardíaca, sem via aérea avançada, qual é a proporção recomendada?

A

15 compressões para 2 ventilações, em qualquer situação

B

5 compressões para 1 ventilação

C

Somente compressões, mesmo com socorrista treinado

D

30 compressões para 2 ventilações

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 4 — Logo depois do choque



O DEA aplicou o choque. O que se faz imediatamente depois?

A

Parar e checar o ritmo no monitor antes de qualquer coisa

B

Retomar as compressões imediatamente, sem pausa para checar o ritmo

C

Aplicar um segundo choque em seguida, sem compressões

D

Aguardar o aparelho mandar comprimir, sem tocar no tórax

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 5 — Checagem de pulso para o profissional de saúde



Profissional de saúde: quanto tempo pode durar a checagem de pulso nessa situação?

A

Até 1 minuto, para não errar

B

No máximo 10 segundos; sem pulso percebido com certeza, começar as compressões

C

Não se checa pulso em nenhuma hipótese

D

Somente depois de 2 minutos de compressões

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Gabarito comentado

1 – **C** 100 a 120 compressões por minuto.

2 – **A** pelo menos 5 cm, sem passar de 6 cm.

3 – **D** 30 compressões para 2 ventilações.

4 – **B** retomar as compressões imediatamente após o choque.

5 – **B** no máximo 10 segundos de checagem de pulso, e só para profissional de saúde.



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Referências — diretrizes de RCP e DEA



AHA — Part 7: Adult Basic Life Support (2025 Guidelines for CPR and ECC).



AHA — Adult Cardiac Arrest Algorithm, 2025 (PDF oficial).



AHA/AAP — Part 6: Pediatric Basic Life Support e Pediatric Cardiac Arrest Algorithm, 2025.



ILCOR — Basic Life Support: 2025 CoSTR (Resuscitation 2025).

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Referências — demais fontes e divergências declaradas



ERC 2025 — European Resuscitation Council Guidelines, Adult Basic Life Support.



AHA 2025 — Part 10, §4.6, circunstâncias especiais (afogamento).



Onde as diretrizes divergirem, as versões aparecem lado a lado, com a origem nomeada.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Em quatro passos, do reconhecimento ao DEA



1

Não responde e não respira normalmente? Trate como parada cardíaca.



2

Acione 192/193 e diga local, o que aconteceu e o que já foi feito.



3

Comprima 100 a 120 por minuto, 5 a 6 cm, com recuo completo.



4

Aplique o DEA assim que ele chegar e volte a comprimir logo após o choque.

Ilustração vetorial original • não demonstra técnica

AULA • NÍVEL BÁSICO

RCP e DEA: os primeiros minutos

Reconhecer. Acionar. Comprimir.

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO

Material didático de apoio

Fonte: Base: AHA 2025 — Part 7: Adult Basic Life Support, 2025 Guidelines for CPR and ECC (Circulation 2025;152(suppl 2), DOI 10.1161/CIR.0000000000001369) [1];
identificação do instrutor fornecida pelo usuário.



Ilustração: unDraw (licença livre), cores adaptadas • cena de apoio